

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Sebastián Quintero Luna

DOCUMENTO

CC 1006123456

FECHA NACIMIENTO

17/02/2003

EDAD

23 años, 3 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Técnico (Sistemas)

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

15/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001245

PROTOCOLO APLICADO

WAIS-III + BDI-II + Evaluación Post-TCE

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Sebastián Quintero Luna	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 1006123456	Ocupación:	Técnico en sistemas
Fecha de nacimiento:	17/02/2003	Ciudad:	Ibagué, Tolima
Edad:	23 años, 3 meses	Acompañante:	Rosa Luna de Quintero
Sexo:	Masculino	Remite:	Neurólogo
Escolaridad:	Técnico (Sistemas)	EPS / Asegurador:	Nueva EPS

MOTIVO DE CONSULTA

TCE leve por accidente de tránsito hace 5 meses. Pérdida de conciencia <30 min. Cefalea post-traumática persistente, quejas de memoria y concentración. Reinicio laboral fallido.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: WAIS-III + BDI-II + Evaluación Post-TCE

Prueba	Dominio	Dur.
VOCABULARIO	Comprensión Verbal	—
SEMEJANZAS	Comprensión Verbal	—
ARITMETICA	Comprensión Verbal	—
DIGITOS	Atención	—
FIG. INCOMPLETAS	Organización Perceptual	—
CLAVE DE NÚMEROS	Velocidad de Proceso	—
CONSTRUCCIÓN CUBOS	Organización Perceptual	—
MATRICES	Organización Perceptual	—
CI COMPRENSIÓN VERBAL	Índice CI	—
CI DEL INDICE ORGNIZACIÓN PERCEPTIVA	Índice CI	—
CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO	Índice CI	—
CI INDICE VELOCIDAD DE PROCESO	Índice CI	—
CI ESCALA TOTAL	Inteligencia General	—
Inventario de Beck BDI-II	Socioemocional - Depresión	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Traumáticos

Niega TEC previo.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Sebastián obtuvo un CIT de 77 (límitrofe), con un perfil asimétrico: IMT=73 es el índice más bajo. El CIT resume pero no captura la variabilidad.

Hallazgos clave

- Velocidad de Proceso severamente descendido ($Z=-2.3\sigma$)

Implicación

El perfil sugiere necesidad de apoyos específicos en las áreas más descendidas; se recomienda intervención focalizada.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Atención y concentración

Atención sostenida y selectiva descendidas. Fatiga atencional acelerada. Mejora con pausas estructuradas.

Memoria

Memoria de trabajo descendida. Codificación deficiente. Reconocimiento mejor que evocación libre (perfil subcortical).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: S06.0 - Secuelas de traumatismo craneoencefálico leve

RESULTADOS CUANTITATIVOS

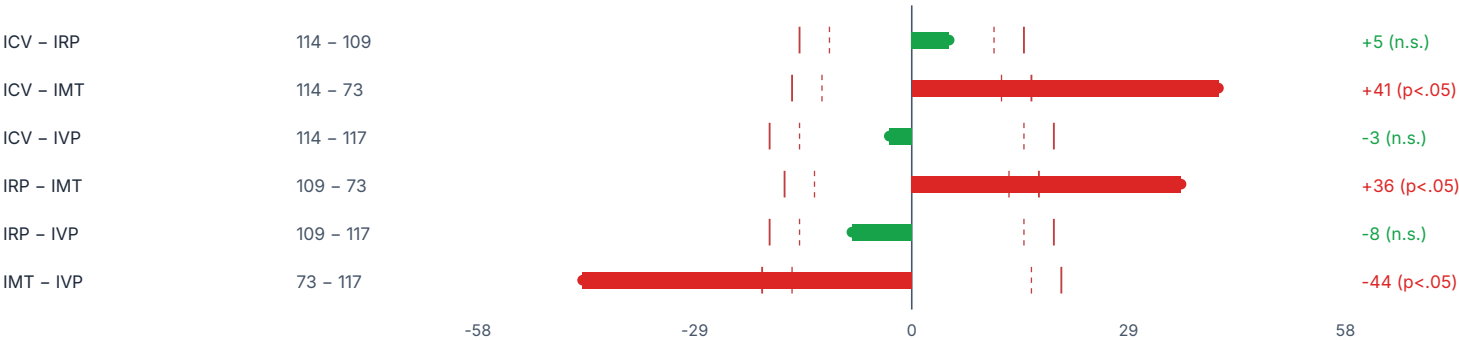
Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

CI COMPRENSIÓN V	CI DEL INDICE OR	CI INDICE MEMORI	CI INDICE VELOCI	CI ESCALA TOTAL	Inventario de Be
114	109	73	117	77	18
Promedio	Promedio	Límitrofe	Promedio	Límitrofe	Leve

Discrepancias entre índices

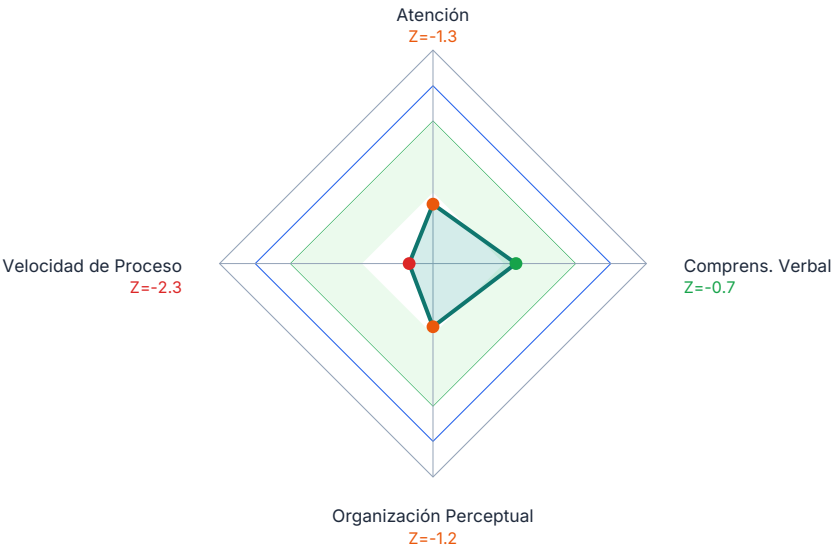
Líneas punteadas: tendencia ($p<.15$). Líneas continuas: diferencia confiable ($p<.05$). La barra central es la diferencia observada entre los dos índices.

Diferencia = valor del primer índice - segundo. Líneas críticas según Wechsler ($p<.15$... y $p<.05$).



Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).

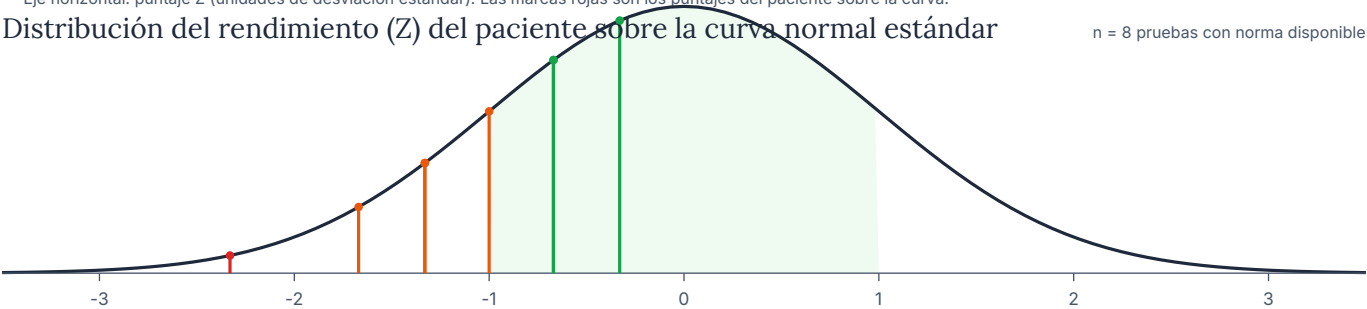


Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 8 pruebas con norma disponible



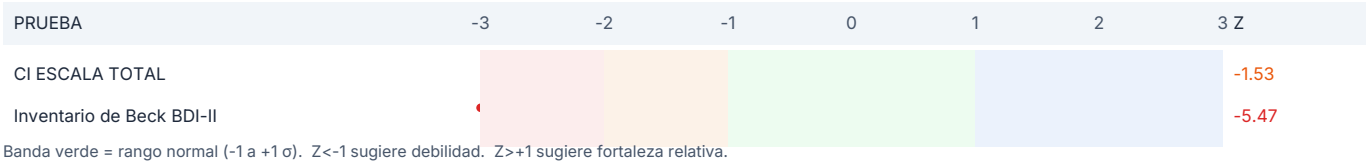
Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
--------	----	----	----	---	---	---	-----

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
VOCABULARIO							-1.00
SEMEJANZAS							-0.67
ARITMETICA							-0.33
DIGITOS							-1.33
FIG. INCOMPLETAS							-1.67
CLAVE DE NÚMEROS							-2.33
CONSTRUCCIÓN CUBOS							-1.33
MATRICES							-0.67
CI COMPRENSIÓN VERBAL							+0.93
CI DEL INDICE ORGNIZACIÓN PERCEPTIVA							+0.60
CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO							-1.80
CI INDICE VELOCIDAD DE PROCESO							+1.13



Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z	BANDA
● Velocidad de Proceso	-2.33σ	severo
● Atención	-1.33σ	moderado
● Organización Perceptual	-1.22σ	moderado
● Comprensión Verbal	-0.67σ	promedio

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
VOCABULARIO	32	7	-1.00	Promedio
SEMEJANZAS	16	8	-0.67	Promedio
ARITMETICA	12	9	-0.33	Promedio
DIGITOS	11	6	-1.33	Límitrofe
FIG. INCOMPLETAS	14	5	-1.67	Límitrofe
CLAVE DE NÚMEROS	35	3	-2.33	Bajo
CONSTRUCCIÓN CUBOS	30	6	-1.33	Límitrofe
MATRICES	16	8	-0.67	Promedio
CI COMPRENSIÓN VERBAL	38	114	+0.93	Promedio
CI DEL INDICE ORGNIZACIÓN PERCEPTIVA	35	109	+0.60	Promedio
CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO	18	73	-1.80	Límitrofe
CI INDICE VELOCIDAD DE PROCESO	26	117	+1.13	Promedio
CI ESCALA TOTAL	78	77	-1.53	Límitrofe
Inventario de Beck BDI-II	18	18	-5.47	Leve

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Sebastián obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 77, ubicándose en la categoría límiterofe (percentil aproximado 6). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IMT (73) y el más alto a IVP (117), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (severamente disminuido, Z=-2.3); atención (moderadamente disminuido, Z=-1.3); organización perceptual (moderadamente disminuido, Z=-1.2).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran CLAVE DE NÚMEROS (Z=-2.33, bajo); FIG. INCOMPLETAS (Z=-1.67, límiterofe); DIGITOS (Z=-1.33, límiterofe). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- CLAVE DE NÚMEROS — bajo (Z=-2.33)
- FIG. INCOMPLETAS — límiterofe (Z=-1.67)
- CONSTRUCCIÓN CUBOS — límiterofe (Z=-1.33)
- DIGITOS — límiterofe (Z=-1.33)
- VOCABULARIO — promedio (Z=-1.00)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Sebastián. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En VOCABULARIO, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En SEMEJANZAS, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En ARITMETICA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En DIGITOS, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En FIG. INCOMPLETAS, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En CLAVE DE NÚMEROS, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

Velocidad de Proceso · severo

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Atención · moderado

- Mantener el foco en una conversación larga (especialmente en reuniones o clases).
- Seguir instrucciones de varios pasos sin perder algún detalle.
- Filtrar estímulos distractores en lugares ruidosos o con mucha gente.

Apoyos sugeridos: Dividir el trabajo en bloques de 20-25 minutos con pausas activas. · Usar temporizadores visuales (Time Timer) y listas de verificación.

Organización Perceptual · moderado

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En VOCABULARIO, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En SEMEJANZAS, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ARITMETICA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En MATRICES, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En CI COMPRENSIÓN VERBAL, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En DIGITOS, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En FIG. INCOMPLETAS, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En CLAVE DE NÚMEROS, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En CONSTRUCCIÓN CUBOS, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: S06

Impresión diagnóstica: S06.0 - Secuelas de traumatismo craneoencefálico leve

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.

ANEXO — DEFINICIONES OPERATIVAS

Convenciones interpretativas utilizadas en este informe

Cociente Intelectual (CI)

Puntuación estándar con media 100 y desviación 15. CIT menor a 70 sugiere déficit; 70-79 límite; 80-89 promedio bajo; 90-109 promedio; 110-119 promedio alto; 120-129 superior; ≥ 130 muy superior.

Puntaje escalar (PE)

Subtests Wechsler — media 10, desviación 3. PE de 8-12 equivale al rango promedio.

Puntuación Z

Desvío en unidades de desviación estándar respecto al grupo normativo. $Z = (PD - \mu) / \sigma$. $Z \leq -1$ indica rendimiento bajo el promedio; $Z \leq -2$ indica déficit clínico.

Percentil

Porcentaje de la población normativa con desempeño igual o inferior al del paciente.

Discrepancia significativa

Diferencia entre índices que excede el umbral de Wechsler. Líneas críticas: $p < .15$ (.....) sugieren tendencia; $p < .05$ () indican diferencia confiable.

Reliable Change Index (RCI)

Jacobson-Truax. $RCI > 1.96$ indica cambio confiable ($p < .05$) entre evaluaciones repetidas. Se reporta sólo en informes de seguimiento.

Glosario: palabras técnicas que usamos

Definiciones operativas de los términos técnicos utilizados en este informe.

CI / CIT

Cociente Intelectual Total. Medida global del funcionamiento intelectual con media 100 y desviación 15. Rango normal: 90-109. < 70 : déficit; 70-79: límite; 80-89: promedio bajo; 90-109: promedio alto; 110-119: superior; ≥ 120 : muy superior.